

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	前列腺肥大 Benign Prostatic Hypertrophy				
編號	A31000-Q03-W-E07	制定者	N13 翁岱鈺	公布日期	98 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 09 月 03 日
版本/總頁數	第 3.8 版/7 頁	審查者	曾翊鍵	檢閱日期	114 年 08 月 07 日

一、目的

讓護理人員了解前列腺肥大的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與護理措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

良性前列腺肥大是男性常見的疾病，隨著年齡增加而逐漸肥大，會壓迫到尿道而造成尿道阻塞症狀，60 歲以上的男性幾乎有 50% 有前列腺肥大的症狀。

（二）症狀

1. 尿流變弱：

由於前列腺肥大壓迫尿道，尿流的直徑變細、變弱，勁道也大減。

2. 頻尿與夜尿增多：

由於排尿不暢，每次排尿不能排淨尿液，膀胱有殘餘尿，於是便會頻頻排尿，尤其是以夜間最為嚴重。

3. 急性尿瀰留：

膀胱積存大量尿液時，會壓著膀胱出口，令肥大的前列腺阻塞了尿道，導致急性尿瀰留。

主題名稱	前列腺肥大	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E07	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	2/7

4. 血尿：

部分病人會發生血尿，多數來源於前列腺本身，凸向尿道腔的前列腺組織很容易出血，少數血尿可來源於膀胱，特別是為了排尿，因膀胱收縮導致出血。

（三）常見檢查

1. 肛門指診：

醫師將食指插入病人直腸內，隔著直腸之前壁，可摸到壁外的前列腺，左右兩側葉之間正常有一條中央溝，前列腺肥大時，它會變淺或消失，食指亦可以憑觸覺感到前列腺的大小和質感。

2. 尿流率測定：

通過尿速儀測定每秒鐘排出尿量的數值，便可以描繪出一條尿流率的曲線。前列腺肥大者會出現排尿時間延長和每秒尿流量減少的情況。

3. 超音波檢查：

可觀察前列腺大小和膀胱內殘餘的小便容量。

4. 膀胱鏡檢查：

觀察前列腺段的尿道，可以看見肥大的前列腺凸出於尿道腔內的現象，和膀胱出口處有前列腺組織突出阻塞的現象。

（四）常見治療

1. 保守療法：

(1) 藥物治療：一般採用藥物來放鬆尿道括約肌，或使前列腺縮小，以利小便順暢。若有需要，再加上抗生素控制局部炎症反應。

(2) 避免喝酒及刺激性的食物。

(3) 教導病人尿急時應速排尿。

(4) 尿滯留嚴重可插入留置導尿管。

2. 手術療法：

(1) 經尿道前列腺切除術：

將內視鏡及器械經由尿道進入前列腺。可目視前列腺，以電刀將增生的前列

主題名稱	前列腺肥大	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E07	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	3/7

腺切除，利用燒灼器控制出血，以等張沖洗溶液經由切除器進入而將切除的組織碎屑沖出。

(2) 雷射前列腺汽化手術：

雷射前列腺汽化手術是利用 0.6 毫米直徑，2000 奈米的 80W 高能量雷射光纖，將阻塞的前列腺肥大組織汽化，以達到解除病人排尿困難的目的。

(五) 護理問題

1. 疼痛不適／手術傷口及膀胱收縮。
2. 易受傷害／留置導尿管和恥骨上引流。
3. 性功能障礙／手術切除前列腺產生逆行性射精及不孕症。

(六) 護理措施

1. 減輕疼痛

- (1) 評估疼痛的特徵及產生的因素，大都是引流管阻塞或是存留導尿管氣囊的刺激引起。
- (2) 告知去除引流管阻塞後，即可減輕疼痛而不需使用止痛劑。

2. 避免各種傷害產生

- (1) 手術當天醫師為預防出血情形，會將尿管牽引與固定，術後需臥床休息尿管牽引之肢體保持平直勿彎曲。
- (2) 經常評估導尿管是否通暢，告知勿牽拉導尿管，以防發生阻塞、出血及尿滯留。
- (3) 發現有膀胱過度膨脹之導尿管阻塞時，宜沖洗導尿管以沖出阻塞物。
- (4) 告知導尿管拔除後可能會發生暫時性的血尿、頻尿及失禁，一段時間後會改善。

3. 提供有關性功能的資訊

- (1) 告知性生活中仍是有勃起及性高潮，只是沒有射精而已。
- (2) 指導在手術後 6-8 週即可恢復性生活。
- (3) 協助接受性諮商之轉介，而能達到圓滿的性生活。

主題名稱	前列腺肥大	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E07	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	4/7

（七）衛教指導

1. 日常活動

- (1) 避免憋尿，有尿液就應解尿。
- (2) 術後六週內應避免長途旅行、騎機車及腳踏車、久坐。
- (3) 術後六週內應避免劇烈運動（如：快跑、爬山、修剪草坪或騎腳踏車）。
- (4) 避免提取重物。
- (5) 盡量採輕鬆柔軟的活動。
- (6) 勿採坐浴或熱敷下腹部。

2. 飲食

- (1) 避免食用辛辣、芥菜等刺激性食物。
- (2) 避免含有酒精或咖啡因的飲料（如：酒、咖啡）。
- (3) 採清淡飲食，避免食用肥肉、肉皮等。
- (4) 多攝取高纖食物（如：蔬菜、水果），以避免便秘。
- (5) 每日攝水量應達 2000cc 以上。

3. 有下列情形應立即回診複查

- (1) 發生大量血尿的情形。
- (2) 發生解尿困難、畏寒、發燒等情形。

（八）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

主題名稱	前列腺肥大	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E07	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	5/7

六、參考資料

- (一) 文玉紅、林立潔(2022)・照顧一位行多項泌尿科手術的患者之手術全期護理經驗・
高雄護理雜誌，39(1)，133-144。https://doi.org/10.6692/KJN.202204_39(1).0011
- (二) 李和惠、林麗秋(2021)・內外科護理學・於胡月娟總校閱，生殖系統疾病病人之護理（六版，210-218 頁）・華杏。
- (三) 黃奕榮(2021)・雷射前列腺剝離剷除手術・臨床醫學月刊，88(5)，702-704。
https://doi.org/10.6666/ClinMed.202111_88(5).0117

七、附件

(略)

主題名稱	前列腺肥大	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E07	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.05.31	1.0	新制定	98 年 05 月 31 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.08.31	2.1	更改主詞之統稱	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
101.08.31.	2.2	護理部改護理部	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
102.08.31.	3.1	修改護理措施及衛教指導部份	102 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.31	3.2	說明護理措施及衛教指導部份修辭潤飾	103 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
104.08.31.	3.3	將年限較久參考文獻刪除並增加近期參考文獻	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.4	新增參考文獻出處於內文中	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.5	第二項新增（含中興分院）。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
108.09.23	3.6	第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過；108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。

主題名稱	前列腺肥大	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E07	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	7/7

修正日期	版本	修正說明	備註
109.08.06	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.07	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.11.08	3.7	1. 第三項第五目護理問題修訂。 2. 更新第六項參考文獻。 3. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.08.03	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.09.03	3.8	刪除第六項參考資料年限較久參考文獻。	113 年 08 月 08 日照護標準組會議通過； 113 年 08 月 14 日護理長會議通過；113 年 09 月 03 日督導會議通過公布。
114.08.07	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	